

Fecha Última Actualización: 23-02-2023 22:05:06

Página 1 de 6

Información Paciente

Nombre : Camila Alejandra Paz Llanquinao
Edad : 27a 0m 27d
Dirección : Uno Norte 1173 Block 1173 Dpto 11

Rut : 19.323.826-2
Fecha Nacto: 27/01/1996
Comuna : Lo Barnechea

N° Archivo : 2301518
Sexo : Femenino
Teléfono : 9 9931 7425

N° Epicrisis
342704

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Upc - Uci Adulto

Fecha Ingreso : 22/01/2023 18:34

Días Estadía: 32

Unidad de Egreso : Upc - Uci Adulto

Fecha Egreso : 23/02/2023 22:02

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

HEPATITIS AGUDA

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

22/01/2023 19:51:25
A.López
INGRESO UCI
Módulo E. Cama 6

ANTECEDENTES: (Datos obtenidos de resumen de traslado)

Médicos: No

Quirúrgicos: niega

Fármacos: no

Alergias: no

Hábitos: OH activo diario desde los 10 años (1.5 L diarios de pisco), TBQ no, drogas ilícitas no.

Inmunizaciones: 3 dosis COVID

SOCIAL: educación media completa. Cesante. Vive con ambos padres.

HISTORIA CLINICA:

Paciente con antecedente de consumo de OH activo desde los 10 años, sin otros antecedentes conocidos, quien consulta el 18.01.2023 en el SAPU por cuadro de 1 mes de evolución caracterizado por compromiso del estado general, dolor abdominal, ictericia, coluria y acolia. Niega fiebre o sangrado digestivo. Se deriva al SU del Hospital del Salvador donde ingresa hipotensa (79/43 mmHg), tendencia a la taquicardia (95 lpm), afebril, sin conflicto ventilatorio. Se describe al examen físico ictericia, bien perfundida, abdomen BDI sin masas ni ascitis, RHA +, sin edema en EEII, sin encefalopatía hepática.

Laboratorio de ingreso:

INR 4.22, BT 32, BD 23, TGO 289, TGP 70. Hb 10.5 con VCM 100, GB 30570, plaquetas 388.000. Creatinina 1.93, BUN 25.6, Na 127. K 2.9. Se realiza TC de AP trifásico que reporta hepatomegalia con esteatosis difusa, leve ascitis en pelvis, sin esplenomegalia.

Ingresa a UCI de HDS el 19.01.2023 bien perfundida, taquicárdica, normotensa, afebril. Requerimientos de 2 L/min de oxígeno. Al examen con asterixis +/+, bradipsíquica.

En relación a falla hepática, se inicia N-acetilcisteína y prednisona 40 mg/día por sospecha de hepatitis alcohólica grave con Maddrey 147. Dentro del estudio etiológico: serologías virales VHA, VHB, VHC VIH no reactivas, IgM VHA negativa, cinética de

Fecha Epicrisis : 23/02/2023 22:05

Página 1 de 6

Fecha Última Actualización: 23-02-2023 22:05:06

Página 2 de 6

Fe normal, recuento IgG normal. Pendientes ANA, AMA, AML. Evaluada por psiquiatría: sin contraindicación para trasplante hepático. Pendiente evaluación por asistente social.

Evoluciona la madrugada del 20.01.2023 con metrorragia importante (> 1000cc) en contexto de menstruación + coagulopatía, asociado a hipotensión, sin compromiso perfusional, con caída de Hb de 10 a 5.5. Se transfunde con 2 U de GR y &U de PFC logrando controlar sangrado. Posteriormente presenta rápido deterioro ventilatorio, se sospecha TRALI vs congestión pulmonar, se inician diuréticos y apoyo con VMNI. Rx de tórax con marcado ascenso diafragmático, aumento de trama vascular bilateral. Evoluciona tórpidamente por lo que se decide y realiza IOT la cual se realiza con 2 operadores al 2do intento por broncoespasmo, buena respuesta a broncodilatadores. Posteriormente sedada con propofol.

En lo nefrológico cursando con AKI, con aumento de creatinina hasta 4, oliguria que progresa a anuria pese a aporte de albumina desde su ingreso y posteriormente con BIC de furosemida con buena respuesta inicial. Evaluada por nefrología cuya última sugerencia es de inicio de TRR.

Evaluada por equipo de hepatología, dado eventos clínicos sugerentes de DHC, se interpreta finalmente como cuadro de ACLF con score CLIF-C 65 pts., indican traslado a centro con disponibilidad de trasplante hepático.

En vista de cuadro clínico, previa autorización de coordinador de UCI, se ingresa para continuar manejo.

Diagnóstico: Daño Hepático Crónico

04/02/2023 04:07:02

J.Gutierrez

Nota:

Paciente quien ingresa de pabellon de 5.5 horas detrasplante hepatico, en regulares condiciones generales, bajo soporte de DVA a dosis de 0.15 mcg/kg/min, sin vasopresina ni signos de hipoperfusión clinica, con JP a hilio hepatico con debito hematico moderados, bajo trasnfusión 2 unidades de GR a su traslado con un total de hemoderivados durante el priocedimiento de Crioprecipitado # 8 unidades, GRE #8 unidades, PFC# 12 unidades, con un estimado de sangrado aproximado de 7 lt. Se reliza ECO Bedside evidenciando cavidades con tamaño y contractilidad conservada, VCI depletada con dimaentro menor a 1 cm, se logra estimar VTI de 19, TAPSE diferido por ventana. Se mantiene bajo monitoreo multimodal, seguimiento x equipo de transplante.

04/02/2023 13:19:50

G.Molina

EVOLUCIÓN UCI

Coordinación trasplante hepático

04/02/2023

Camila Alejandra Paz Llanquinao

Motivo de ingreso a UCI

·Trasplante hepático ortotópico 03/02/2023

oTIF: . 4:20 H

oHOPE: 4:22 H

oTIC: 24 min.

o1 gramo metilprednisolona

oBasiliximab 20 mg

oSoporte transfusional masivo

·Crioprecipitados 8 U

·PFC 12 U

·Glóbulos rojos 10 U

·CELL SAVER 2000 cc

·Sangrado aproximado 7.000 cc

·Noradrenalina hasta 0.45 ug Kg min

·Vasopresina hasta 0.2 UI min

Fecha Epicrisis : 23/02/2023 22:05

Página 2 de 6

Intercurrencias

- Shock hipovolémico en el post operatorio inmediato
- o Hematocrito 9.
- Soporte transfusional
- En plan quirúrgico urgente

Paciente muy grave, si bien el laboratorio de ingreso en el postoperatorio inmediato demostró buena función inicial del injerto, en el laboratorio de la mañana (4H de diferencia) se observó caída de hematocrito, aumento de lactato, SVCO2 baja, aumento de bilirrubina y enzimas hepáticas que por más que fuesen esperables en el contexto, se re controlaron a las 5 horas encontrando hematocrito alrededor de 9, lactato superior a 100; se da aviso a cirugía, se transfunde 4 unidades de glóbulos rojos, se solicita ROTEM, CT corto, CFT prolongado, se solicita soporte transfusional con plaquetas, crioprecipitados, se solicita PFC para necesidades en pabellón.

Planes y problemas

En plan quirúrgico urgente, reanimación con hemoderivados y corrección de coagulación.

11/02/2023 10:28:58

G.Molina

EVOLUCIÓN UCI

Paciente en proceso de despertar, intercurrió con nuevo evento séptico que requirió cambio de accesos venosos e inició terapia antibiótica dirigida aye con LINE. Se interpretó en ese contexto hiperlactacidemia que en la fecha va en descenso con lactato de 26.9 previo a 28.6, sin parámetros para administración de volumen, llenado capilar 3 segundos, sin necesidad de vasoactivos.

Bilirrubina 12.41, TGO 113, TGP 115, todas similares a la de ayer; impresiona función estable del injerto pero llama la atención que aún no logra aclarar de forma adecuada la bilirrubina.

Se evaluará la necesidad de nueva imagen axial de abdomen.

BUN 47 y creatinina 1.84.

PCR 27, afebril, con LINE desde ayer, rescatar cultivos de punta de cateter de hemodiálisis retirado ayer.

Hipokalemia que se carga.

Hipernatremia. Agua libre por SNG.

Sin mayor conflicto de intercambio gaseoso.

13:31:00

E.Martinez

Trasplante Hepatico

Paciente femenino de 27 años de edad, conocida por equipo. Trasplante Hepatico, THO el 03-02-23, Reintervenida el 04-02-23 en el contexto de importante hemoperitoneo (sangrado de arteria ovarica). Al momento de evaluacion conectada a VM, impresion conexion parcial con el medio. Actualmente sin uso de drogas vasoactivas. Conectada a Hemodialisis.

Injerto: INR 1.46, TGP 115, TGO 113, GGT 303, BT 12.41. Se observa mejoría discreta de aminotransferasas y de la bilirrubina.

IS: Paciente recibió bolus de Metilprednisolona y Basiliximab 2 dosis. Actualmente con Metilprednisolona 20 mg cada 8 horas. Tacrolimus 1 mg sublingual cada 12 horas (abrir capsula). Niveles de Tacrolimus en 15.7. Los niveles pueden ser explicados en el contexto del uso de Fluconazol.

Infeccioso: Paciente con Fluconazol profilactico. El día de hoy se asocio Linezolid dado infección de punto de partida de cateter por Enterococcus faecium Van B. Considerar iniciar profilaxis con Aciclovir 200 mg cada 12 horas.

Renal: paciente en apoyo dialítico al momento de evaluación. Creat 1.84, Na 152, K 2.78.

Fecha Última Actualización: 23-02-2023 22:05:06

Página 4 de 6

Plan:

1. Omitir dosis nocturna de hoy (11-02-23) de Tacrolimus. Omitir dosis de Tacrolimus de la mañana del 12-02-23.
2. Reiniciar Tacrolimus mañana a las 9 PM (0.5 mg via sublingual, abrir capsula). Discutido en equipo.
3. Metilprednisolona 40 mg EV al día.
4. Aciclovir 200 mg via SNG cada 12 horas.
5. Pruebas hepáticas mañana en AM.
6. Nuevos niveles de Tacrolimus el 13-02-23.
7. PCR de CMV el 13-02-23.

Paciente cursa internación en UPC por falla hepática fulminante con requerimiento de Trasplante Hepático el 03/02 con, múltiples intercurencias y con requerimiento de TQT por weaning prolongado.

Hemodinamia: Con DVA 0.09, hiperlactatemia con predictores de respuesta a volumen negativos.

Respiratorio: PAFI 457, se aumenta sedación y se agrega Fentanilo y se cambia modalidad a A C/V. ventilación protectora.

TQT con cánula cerca de carina por el momento sin complicaciones, en plan de cambio el día lunes.

Hepático: Aumento de enzimas hepáticas, bilirrubina e INR. Se realiza Angio TC que informa

Foco estenótico hemodinámicamente significativos (70%) y en anastomosis de la arteria hepática, según descrito.

Disminución de calibre de la arteria hepática, derecha e izquierda y escasa representación de las ramas intraparenquimatosas, probablemente determinado por un vaso contracción.

Áreas de necrosis en el lóbulo hepático derecho, de mayor extensión en comparación a estudio de referencia, según descrito.

Estabilidad en tamaño de hematoma peri hepático - Subscapular derecho, sin signos de sangrado activo.

Leve derrame pleural bilateral.

En seguimiento por equipo de cirugía en plan de exploración quirúrgica el día de hoy, se da aviso a familia.

Infeccioso: Paciente en tratamiento con Linezolid cubriendo IAC por enterococ faecium VAN B, hoy por deterioro hepático y ascenso de noradrenalina se decide ampliar esquema ATB, se agrega Imipenem, Anidulafungina, Ganciclovir.

Se tomaran cultivos en pabellón.

18/02/2023 20:36:23

A. Betina

NOTA UPC:

Paciente regresa de Pabellón, según consta en protocolo quirúrgico:

~~Bellagos~~ subcutáneo con signos de infección. Hemoperitoneo perihepático con signos de infección. Arterias, porta y venas hepáticas permeables. Sin sangrado activo.

Hígado colestásico. Hematoma hiliar con compresión extrínseca de la arteria hepática, la cual no presenta signos de disección o trombosis.

~~23/02/2023~~
23/02/2023

NOTA UPC:

Se realiza exámenes de control Post diálisis.

HTO 17 HB 5.8, se solicita 4 UGR.+ Albumina 4%

Bilirrubina/Transaminasas a la baja .Lac 83

Acidosis metabólica

Noradrenalina 0.12

Se solicita Angio TC abdominal de urgencia, se da aviso a Equipo de Tx Hepático sin evidencia de sangrado activo (p) informe.

Paciente se traslada con apoyo de Ambu, al terminar el estudio cuando retorna a UPC presenta desaturación 76% en relación a falta de disponibilidad de Oxígeno < 1 min , al llegar a la unidad se conecta a ventilador y no ciclaba , evolucionando con bradicardia , Sat 45% , cánula de TQT impresiona desplazada , se decide intubación de urgencia.

En primer lugar se inicia oxigenación con ambu + cánula de mayo recuperando oxigenación >90% se retira TQT y se intuba.

ROTEM: Trombo sin déficit para corregir.

Fecha Epicrisis : 23/02/2023 22:05

Página 4 de 6

Fecha de Impresión : Martes, 05 de Mayo de 2026 17:41

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar

23/02/2023 08:21:04

A.Domínguez

Camila, 27 años

Grave

Deterioro de HDN, re- IOT

Leucopenia severa con neutropenia

Sin rebote de transaminasas

pre- informe de biopsia : necrosis 10%, elementos de hepatitis isquemica

Podria estar presentando RAM a ganciclovir

hoy PCR CMV (entrega orden a enfermeria)

favor matener cobertura fungica

23/02/2023 15:35:30

G.Molina

EVOLUCIÓN UCI

oTraqueostomía --> 17/02/2023

·Deterioro de función del injerto

oHematoma peri hepático

oEstenosis de arteria hepática

·Biopsia hepática /10 % de necrosis

oDrenaje de hematoma peri hepático

·Infección por CMV

oGanciclovir

·Anemia aguda

o¿HDA?

·Hipoxemia

oPérdida de vía aérea (traqueostomía)

·Intubación de urgencia

·Re colocación de traqueostomía por VMI con fuga superior al 50%. Paciente inventilable, procedimiento de urgencia el 23/02/23

Paciente grave; posterior a hipoxemia que se presentó a primera hora esta mañana y requirió:

·Recolocación de traqueostomía de manera urgente por ventilación mecánica por tubo endotraqueal con fuga superior al 50%.

·Se realizó recolocación de cánula #8 por el ostoma previo con guía por fibrobroncoscopia, sangrado importante que se evacuó rápidamente de la vía aérea, al inicio del procedimiento persistentemente hipoxémica, se logra terminar procedimiento con SatO2 90% y FiO2 100%.

·A la revisión con Fibrobroncoscopia se extraen pequeños coágulos, vía aérea permeable.

Dr. Andrés Aquevedo ¿ operador

Dr. Guillermo Molina ¿ fibrobroncoscopia

Evoluciona con ligera mejoría inicial para posteriormente intercorre con shock refractario, al momento con noradrenalina y adrenalina en dosis altas, acidosis mixta de difícil control (se administró bicarbonato y se aumentó el volumen minuto en la ventilación mecánica), leucopenia con neutropenia, caída de hematocrito de 28 a 24 en aproximadamente 7 horas, falla respiratoria mixta PaFi 50.3, realizo Ecoscopia cardiaca: VD menor a VI, TSVI 17, contractibilidad conservada, sugiero inicio de vasopresina, evaluar mayor soporte transfusional, aporte de bicarbonato de sodio y corticoides (hidrocortisona 200 mg), inmunosupresión suspendida

Mal pronóstico a corto plazo, se permite acompañamiento familiar.

23/02/2023 19:18:10

S.De La Maza

Epicrisis Hospitalaria

ESTADO: DEFINITIVA



Fecha Última Actualización: 23-02-2023 22:05:06

Paciente de extrema gravedad.
NAD 1 ug/kg/min, Adrena 0.45 ug/kg/min, Vasopresina 0.03 UI/Hr.

Control de exámenes PM:

PAFI 50.

Lactico 235

pH 7.0, pCo2 50, HCO3 13.5

LDH 1920

Troponinas 1080 previa --> 100 actual.

Hb 8.5 (9.6), 110 blancos con RAN CERO, plt 75.000

Falla hemodinámica, ventilatoria, hematológica, renal.
HDA via SNE.

Mal pronóstico.

Familiares acompañando a paciente.

23/02/2023 21:35:23

S.De La Maza

Registro en diferido:

A las 19:45 se constata ausencia de signos vitales.

Se certifica fallecimiento y se entrega certificado de defunción a familiares.

Diagnóstico de Egreso

ENFERMEDAD TOXICA DEL HÍGADO CON OTROS TRASTORNOS HEPATICOS - Falla hepatica aguda sobre cronica en trasplantada hepática.
Shock refractario multifactorial
Falla orgánica múltiple

Condición de Egreso Fallecido

Egreso con Catéter Doble J:NO

FALLECIDA

Plan Post Alta

FALLECIDA

Indicaciones

Tipo de Reposo :

Régimen Alimentario :

Medicamentos :

Controles

INTERNO

Becado/Residente


Simon De La Maza Fontecilla
Médico Tratante (Staff)

Fecha Epicrisis : 23/02/2023 22:05